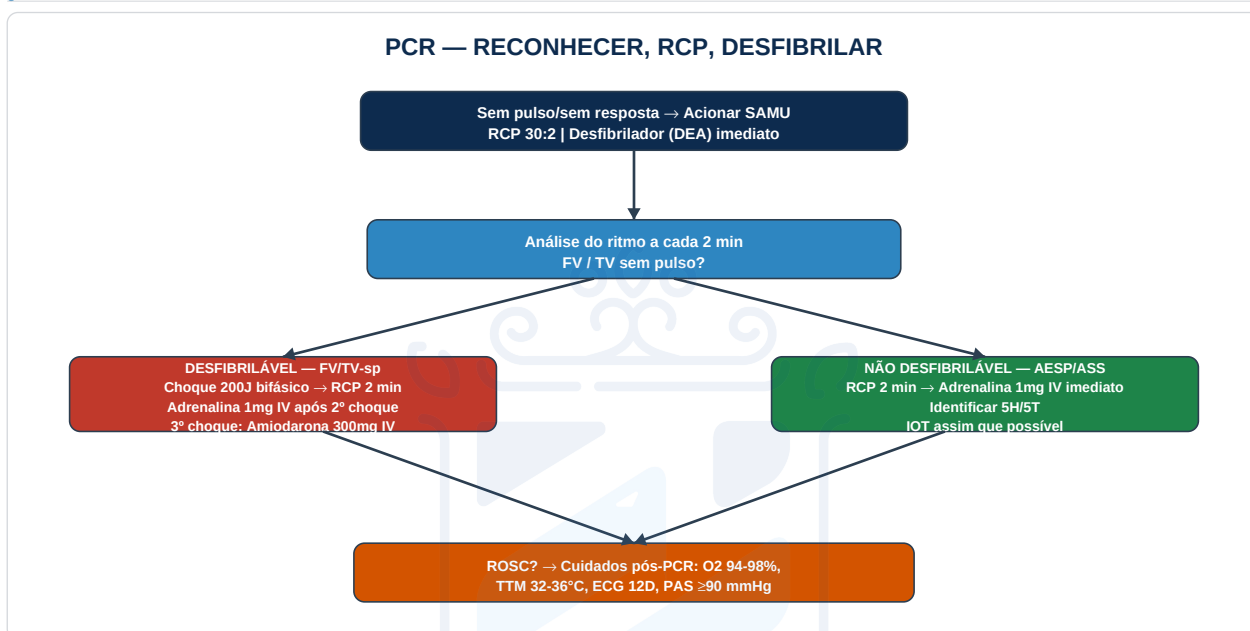


PCR NO ADULTO — ACLS 2020

ALGORITMO ACLS — FV/TV vs AESPI/ASS



CAUSAS REVERSÍVEIS — 5H/5T

5 Hs (tratar imediatamente)

- Hipóxia → ventilar O2 100%
- Hipovolemia → SF 1-2L IV/IO rápido
- Hipotermia → aquecimento externo/interno
- Hipo/Hipercalcemia → gasometria, correção
- H+ (acidose) → HCO₃ 1mEq/kg se pH <7,1

5 Ts (tratar imediatamente)

- Tensão pneumotórax → agulha 2ºEIC MCL
- Tamponamento → pericardiocentese
- Trombose coronária → ICP emergência
- Trombose pulmonar → trombolítico (alteplase)
- Tóxico → carvão, antídoto específico

MEDICAMENTOS — ACLS 2020

Fármaco	Dose	Indicação / Timing
Adrenalina	1 mg IV/IO a cada 3-5 min	FV/TV: após 2º choque; AESPI/ASS: imediatamente
Amiodarona	300mg IV bolus; 2ª dose 150mg	FV/TV refratária após 3º choque
Lidocaína	1-1,5 mg/kg IV	Alternativa à amiodarona (se indisponível)
MgSO ₄	1-2g IV em 1-2 min	Torsades de Pointes / hipomagnesemia
Bicarbonato	1 mEq/kg IV	Acidose grave, hipercalcemia, intox. tricíclicos
Atropina	REMOVIDA das diretrizes ACLS	Não usar em PCR (sem evidência de benefício)

RCP DE ALTA QUALIDADE — SALVA VIDAS

FUNDAMENTOS INEGOCIÁVEIS

- Frequência: 100-120 compressões/minuto — monitor de feedback é ideal
- Profundidade: ≥ 5 cm (não > 6 cm) — permitir retorno torácico completo
- Minimizar pausas: < 10 segundos para análise de ritmo e choque
- Pré-IOT: 30:2 | Pós-IOT: 1 ventilação a cada 6 seg (assíncrona)
- Trocar compressor a cada 2 min; PETCO₂ < 10 mmHg = RCP ineficaz ou prog. grave
- Fração de fluxo (chest compression fraction) alvo: $\geq 60\%$

ORGANIZAÇÃO DO TIME — PAPÉIS NA PCR

LIDERANÇA EM CÓDIGO

- ☐ Líder: análise de ritmo, decisão de choque, 5H/5T, comunicação em alça fechada
- ☐ Compressor: qualidade, 100-120/min, ≥ 5 cm, trocar a cada 2 min
- ☐ Via aérea: máscara-bolsa → IOT após 1º ciclo; waveform capnografia
- ☐ Acesso/drogas: periférico antecubital ou IO (esterno/tíbia) se falha periférica
- ☐ Registrador: hora da PCR, hora das drogas, hora dos choques, duração
- ☐ Causas reversíveis (5H/5T): investigar DESDE o início, não só ao final

CUIDADOS PÓS-ROSC

APÓS RETORNO À CIRCULAÇÃO ESPONTÂNEA

- O₂: SpO₂ 94-98% (evitar hiperóxia — mortalidade aumenta); PETCO₂ 35-45 mmHg
- PA: manter PAS ≥ 90 mmHg; noradrenalina se necessário; evitar hipotensão
- ECG 12 derivações: IAMCSST → cateterismo emergencial (ICP primária)
- Controle direcionado de temperatura (TTM): 32-36°C por 24h se coma pós-PCR
- Glicemia: alvo 140-180 mg/dL; evitar hipoglicemia e hiperglicemia
- Prognosticação neurológica: aguardar ≥ 72 h após ROSC (ou pós-reaquecimento)

SUSPENSÃO DA RCP — CRITÉRIOS

QUANDO ENCERRAR

- PCR não presenciada, sem RCP leigo, ritmo não desfibrilável por > 20 -30 min
- PETCO₂ < 10 mmHg persistente após ≥ 20 min de RCP de alta qualidade
- Doença terminal conhecida + diretivas antecipadas de vontade
- Lesão incompatível com a vida (trauma com decapitação, pcr traumática sem sinais de vida)
- Hipotermia grave (< 28 -30°C): RCP prolongada — 'not dead until warm and dead'
- Pediatria: suporte mínimo de 30-60 min antes de decidir suspensão

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

AMRIGS / Adaptada

Paciente em FV refratária após 3 choques de 200J (bifásico). Além de continuar a RCP, qual a próxima droga a ser administrada?

- A) Atropina 1 mg IV
- B) Amiodarona 300 mg IV em bolus
- C) Adenosina 6 mg IV
- D) Digoxina 0,5 mg IV
- E) Verapamil 5 mg IV

QUESTÃO 2

CFM / Adaptada

Na AESP com jugular distendida e ausência bilateral de murmúrio vesicular, qual causa reversível deve ser tratada de imediato?

- A) Hipovolemia — SF rápido
- B) Hipercalemia — bicarbonato
- C) Pneumotórax hipertensivo — agulha 2ºEIC MCL
- D) Acidose — bicarbonato
- E) Hipotermia — aquecimento

QUESTÃO 3

SES-GO / Adaptada

Qual afirmativa sobre qualidade de RCP no adulto é CORRETA segundo as diretrizes ACLS 2020?

- A) Frequência ideal de 60-80/min para evitar fadiga do compressor
- B) Profundidade de 2 cm para evitar fraturas de costelas
- C) 100-120/min, profundidade ≥ 5 cm (não > 6 cm), retorno torácico completo, pausas < 10 s
- D) Após IOT, ventilações devem ser sincronizadas 30:2 com as compressões
- E) Fração de fluxo (CCF) alvo é $\geq 20\%$

QUESTÃO 4

FMUSP / Adaptada

Paciente em ROSC após PCR, em coma, com SpO₂ 100% em FiO₂ 1,0. Qual conduta é CORRETA?

- A) Manter FiO₂ 1,0 para máxima oxigenação cerebral
- B) Titular O₂ para SpO₂ 94-98% e iniciar controle de temperatura 32-36°C por 24h
- C) Iniciar heparina plena para prevenir trombose
- D) Alta da UTI após 24h se hemodinamicamente estável
- E) Aguardar 7 dias para prognosticação neurológica

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

O PETCO₂ < 10 mmHg persistente após ≥ 20 minutos de RCP de alta qualidade indica:

- A) Boa perfusão cerebral, continuar a RCP
- B) Hipocapnia — ventilar mais devagar
- C) Prognóstico desfavorável — pode orientar a suspensão da reanimação
- D) Indica intubação imediata
- E) Necessidade de amiodarona adicional

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Amiodarona 300mg IV em bolus é indicada na FV/TV refratária após o 3º choque (2ª dose: 150mg). Lidocaína é alternativa. Atropina foi removida das diretrizes ACLS 2010 por ausência de benefício em PCR.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Jugular distendida + ausência bilateral de MV = pneumotórax hipertensivo (5T). Tratamento imediato: agulha de alívio no 2º EIC linha hemiclavicular, seguida de dreno de tórax. Tamponamento também distende jugular mas sem ausência de MV bilateral.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Parâmetros de alta qualidade: 100-120/min, profundidade ≥ 5 cm (não > 6 cm), retorno torácico completo, pausas < 10 s, CCF $\geq 60\%$. Após IOT: 1 ventilação a cada 6 segundos, assíncrona.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Hiperóxia pós-ROSC é prejudicial — titular SpO_2 94-98%. TTM 32-36°C por 24h indicado em coma. Se ECG mostra IAMCSST → cateterismo emergencial. Prognosticação: aguardar ≥ 72 h após ROSC.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

PETCO₂ reflete perfusão pulmonar e débito cardíaco. Valores < 10 mmHg após ≥ 20 min de RCP de qualidade indicam prognóstico desfavorável e podem orientar suspensão. Valores aumentando sugerem ROSC iminente.

SM24
Suporte ao Plantão Médico